



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زينب على عبد الظاهر عبد القادر

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : العياط

رقم البطاقة : 27712152100649 رقم التليفون : 01205382878

العنوان : العياط تاريخ تسجيل الإستمارة : 25-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 15-12-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129]

قسم العلاج :
الأورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زينب علي عبد الظاهر عبد القادر National ID: 27712152100649	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

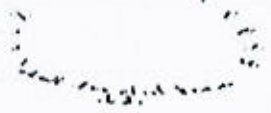
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:
1- Name: زينات علي محمد الظاهر عبدالعزیز
2-ID number: 27712152100649

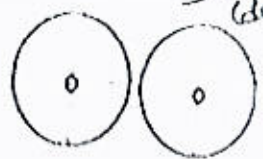
Sex:

MDT form
3- Medical number:
Female
Patient Age: 46 Y

83151607
Old Med:

2554-2023

MBC to L
Gda. no



Family history

marital status

Co morbidity

Phone

NRS Score

Menopausal status

01114547278

BMI

GROUP

A

REASON OF MDT NEW

Date of MDT 2023-07-12 (3)

Breast Imaging:

Clinical data

Meta Workup:

DX:	ER:	PR:	Her 2 Neu:	SISH:	KI67:
	+ve	+ve	-ve		
T	N		M		

Sonoinammography

PATIENT HISTORY

acase of denovo mets breast to bone 6/2020 , recolved 1st line AI with progression in breast
--> shifted to aromasine +palbo with SD dis.--> breast
CR--> bone
reffered for resuming treatment

MDT OUTCOME & PLAN

baseline cts & ttumor markers

continue aromasine +palbo +/- zoladex according to hormonal assay

MEDICAL ONCOLOGY	SIGNATURE	
SURGERY	02/07/2023	RADIOLOGY
Psychiatric	02/07/2023	PATHOLOGY
		Nutrition



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zäher Abdel Kader	Date: 11/08/2024
Exam: C.T. CHEST WITH CONTRAST	Age: 46 Year(s)
Medical ID: 2654/2023	Pat. ID: 42287

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Compared to previous study dated 25/9/2023; the current study revealed

I-Chest:

- Still noted bilateral axillary level I and II enlarged lymph nodes.
- Clear rest of both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Bilateral thyroid lobes hypodense nodules, for US.

II-Abdomen and pelvis:

- The liver is still seen mildly enlarged with diffuse homogenous low parenchymal CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zaher Abdel Kader	Date : 11/08/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

- Still seen calcified uterine fibroid and right adnexal lesion measures about 3.3x3.5 cm containing calcific foci? subserous fibroid.
- No abdominal or pelvic collections.

III-The scanned skeleton:

- Still seen multiple vertebral small lytic lesions yet no vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

Follow up status showing no gross time interval changes since study dated 25/9/2023.

Signature Dr. Walid Mohamed, MD

22/08/2024 06:10 ,

ALI, ZAYNEB Patient ID: 123022626 - DOB: 15-Dec-1977 Date: 03-May-2025
Patient Lastname: Ali
Patient Firstname: Zayneb
HIS Patient ID: 123022626
RIS Patient ID: 340505
Date of Birth: 15/12/1977

Procedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (3/5/2025)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.

" Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.

" Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.

" Both kidneys are visualized

Conclusion:

" No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obliged
Mahmoud Akram
Mohamed Abdeltawab, MSc

===== REPORT TEXT ENDE =====



Histopathology report

Report Number: 353

12:46	: قسوس ا. سلام الدولة	: النوع
13:06	: تاريخ المقتول	: التاريخ

م. الريتر :	زينب حامى عبدالقادر
م. :	41 Y
روح الله العتيق :	
الحبيب الحارث :	د. دة المرأة
م. :	صحة المرأة

Primary sample :

fight breast core biopsy

comment :

Gross examination:

4 cores of greyish white tissue (1.1)

Microscopic examination :

cores of breast tissue involved by invasive cords and dissection of small malignant cells with hyperchromatic nuclei that are arranged in non-cohesive pattern.

Referral Lab :

Comment :

Diagnosis :

RIGHT BREAST MASS 8 OPS / INVASIVE LOBULAR CARCINOMA, GRADE I

Pathologist

د/ اذلر، وازی،

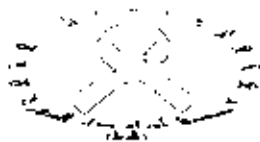
Lab Director: د/ نزيه ماهر

19 El-Shelbi Rehab Street, Abaskun, Cairo
Tel: (00979) 945644 - 795036 Fax: (00979) 945644
Mobile: 01144297292
Website: <http://www.healthlab.net>
email: pathologychi@yahoo.com
facebook: www.facebook.com/healthlab.net

• This Test is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By E.A.

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

Page 3 of 1



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



ERM036726062

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : زينب علي عبدالقادر عبدالقادر

Sex:

3- Medical number:

Female

83151607

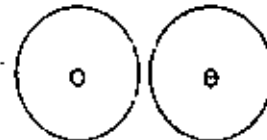
Old Med :

Old Med :

2554-2023

2-ID number:

Patient Age : 47 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01114547278

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

REASON

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2024-12-02



Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal
status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

partial radiological response of the rt breast malignant mass

BIRASD 6

single Rt axillary indeterminate LM

Mets Workup :

bone scan:free

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

Ki67

BX COMMENT

ER COMMENT

+ve

PR COMMENT

+ve

Her 2 Neu COMMENT

-ve

SISH COMMENT

T

N

M

1 bone

Sonomammography

PATIENT HISTORY

acase of denovo mets breast to bone 6/2020 , received 1st line AI with progression in breast

--> shifted to zoladex + aromasine +palbo received palbo for 3 months only

She was irregular on ttt and kept of Aromasin only with excellent response

bone scan: CR

CT CAP: CR

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

In view of CR,

keep on Zoladex + Aromasin + Zameta/3m

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

ALI, ZAYNEB Patient ID: 123022626 DOB: 15-Dec-1977 Date: 03-May-2025

Patient Lastname: Ali

Patient Firstname: Zayneb

HIS Patient ID: 123022626

RIS Patient ID: 340505

Date of Birth: 15/12/1977

Procedure: 70030, Bone Scan

Medical Question:

Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (3/5/2025)

• Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

- " No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- " Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- " Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- " Both kidneys are visualized.

Conclusion:

" No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Mahmoud Akram

Mohamed Abdeltawab, MSc

===== REPORT TEXT ENDE =====



Histopathology report

Report Number: 355

Female	النوع	زينة عى عبدالظاهر	سم المريض
41 Y	العمر		السن
03/06/2020 12:46	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة
07/06/2020 13:06	تاريخ تافيد		طالب التحليل
		صحة المرأة	عذبة

Primary sample :

right breast core biopsy

comment :

Gross examination :

4 cores of greyish white tissue (1.1)

Microscopic examination :

cores of breast tissue involved by invasive cords and trabeculae of small malignant cells with hyperchromatic nuclei that are arranged in non cohesive pattern

Referral Lab :

Comment :

Diagnosis :

RIGHT BREAST MASS BIODPS / INVASIVE LOBULAR CARCINOMA, GRADE II

Pathologist:

د. ايثار رضى

Lab Director:

د. نورا ماهر

رئيس على عبد السلام

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (29/5/2024)

• Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP **Revealed:**

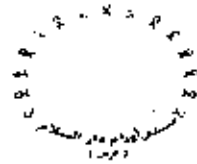
- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Mohamed Abdeltawab, MSc



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zaher Abdel Kader	Date : 04/11/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Right breast pathologically proven malignant mass on NACT for assessment.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Complementary ultrasound revealed
- **Right breast:**
- No right breast residual suspicious solid mass lesions
- No pathological right axillary LNs
- Free infra and supra-clavicular regions.
- **Left breast:**
- Single left axillary LN measured 2cm showing increased cortical thickness reaching 4mm
- No breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.

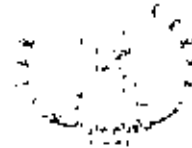
Opinion:

- Partial radiological response of the right breast malignant mass (BIRADS 6)
- Single left axillary indeterminate LN for US follow up

Yours truly

Signature Dr. basma mohmaed

04/11/2024 3:24 PM



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zaher Abdel Kader	Date : 11/08/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Compared to previous study dated 25/9/2023; the current study revealed

I-Chest:

- Still noted bilateral axillary level I and II enlarged lymph nodes.
- Clear rest of both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Bilateral thyroid lobes hypodense nodules, for US.

II-Abdomen and pelvis:

- The liver is still seen mildly enlarged with diffuse homogenous low parenchymal CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zäher Abdel Kader	Date : 11/08/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

- Still seen calcified uterine fibroid and right adnexal lesion measures about 3.3x3.5 cm containing calcific foci? subserous fibroid.
- No abdominal or pelvic collections.

III- The scanned skeleton:

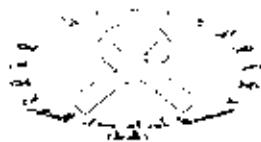
- Still seen multiple vertebral small lytic lesions yet no vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

Follow up status showing no gross time interval changes since study dated 25/9/2023.

Signature ~~Dr. Walid Mohamed~~ MD

22/08/2024 06:10 ,



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



ERM036726062

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : زينب عيسى عبدالقادر

Sex:

3- Medical number:

Female

83151607

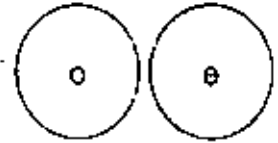
Old Med :

Old Med :

2554-2023

2-ID number:

Patient Age : 47 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01114547278

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

REASON

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

2024-12-02

Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal
status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

partial radiological response of the rt breast malignant mass

BIRASD 6

single Rt axillary indeterminate LM

Mets Workup :

bone scan:free

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

Ki67

BX COMMENT

ER COMMENT

+ve

PR COMMENT

+ve

Her 2 Neu COMMENT

-ve

SISH COMMENT

T

N

M

1 bone

Sonomammography

PATIENT HISTORY

acase of denovo mets breast to bone 6/2020 , received 1st line AI with progression in breast

--> shifted to zoladex + aromasine +palbo received palbo for 3 months only

She was irregular on ttt and kept of Aromasin only with excellent response

bone scan: CR

CT CAP: CR

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

In view of CR,

keep on Zoladex + Aromasin + Zameta/3m

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition

ALI, ZAYNEB Patient ID: 123022626 DOB: 15-Dec-1977 Date: 03-May-2025

Patient Lastname: Ali

Patient Firstname: Zayneb

HIS Patient ID: 123022626

RIS Patient ID: 340505

Date of Birth: 15/12/1977

Procedure: 70030, Bone Scan

Medical Question:

Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (3/5/2025)

• Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

- " No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- " Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- " Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- " Both kidneys are visualized.

Conclusion:

" No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Mahmoud Akram

Mohamed Abdeltawab, MSc

===== REPORT TEXT ENDE =====



Histopathology report

Report Number: 355

Female	النوع	زينة عى عبدالظاهر	سم المريض
41 Y	العمر		السن
03/06/2020 12:46	تاريخ الاقدام العينة		تاريخ اخذ العينة
07/06/2020 13:06	تاريخ تافيد	صحة المرأة	طالب التحليل
		صحة المرأة	عذبة

Primary sample :

right breast core biopsy

comment :

Gross examination :

4 cores of greyish white tissue (1.1)

Microscopic examination :

cores of breast tissue involved by invasive cords and trabeculae of small malignant cells with hyperchromatic nuclei that are arranged in non cohesive pattern

Referral Lab :

Comment :

Diagnosis :

RIGHT BREAST MASS BICPS / INVASIVE LOBULAR CARCINOMA, GRADE II

Pathologist:

د. ايثار رضى

Lab Director:

د. نورا ماهر

زست علی عبدالظام

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (29/5/2024)

• Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP **Revealed:**

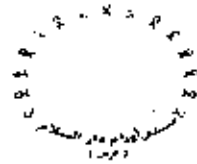
- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Mohamed Abdeltawab, MSc



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zaher Abdel Kader	Date : 04/11/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Right breast pathologically proven malignant mass on NACT for assessment.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Complementary ultrasound revealed
- **Right breast:**
- No right breast residual suspicious solid mass lesions
- No pathological right axillary LNs
- Free infra and supra-clavicular regions.
- **Left breast:**
- Single left axillary LN measured 2cm showing increased cortical thickness reaching 4mm
- No breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.

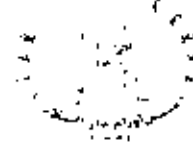
Opinion:

- Partial radiological response of the right breast malignant mass (BIRADS 6)
- Single left axillary indeterminate LN for US follow up

Yours truly

Signature Dr. basma mohmaed

04/11/2024 3:24 PM



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zaher Abdel Kader	Date : 11/08/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Compared to previous study dated 25/9/2023; the current study revealed

I-Chest:

- Still noted bilateral axillary level I and II enlarged lymph nodes.
- Clear rest of both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Bilateral thyroid lobes hypodense nodules, for US.

II-Abdomen and pelvis:

- The liver is still seen mildly enlarged with diffuse homogenous low parenchymal CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zäher Abdel Kader	Date : 11/08/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

- Still seen calcified uterine fibroid and right adnexal lesion measures about 3.3x3.5 cm containing calcific foci? subserous fibroid.
- No abdominal or pelvic collections.

III- The scanned skeleton:

- Still seen multiple vertebral small lytic lesions yet no vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

Follow up status showing no gross time interval changes since study dated 25/9/2023.

Signature ~~Dr. Walid Mohamed~~ MD

22/08/2024 06:10 ,

زست علی عبدالظام

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (29/5/2024)

• Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated

Mohamed Abdeltawab, MSc



Patient Name: Zainab Ali Abdel-Zaher Abdel Kader	Date : 11/08/2024
Exam : C.T. CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Compared to previous study dated 25/9/2023; the current study revealed

I-Chest:

- Still noted bilateral axillary level I and II enlarged lymph nodes.
- Clear rest of both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Bilateral thyroid lobes hypodense nodules, for US.

II-Abdomen and pelvis:

- The liver is still seen mildly enlarged with diffuse homogenous low parenchymal CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zaher Abdel Kader	Date : 11/08/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

- Still seen calcified uterine fibroid and right adnexal lesion measures about 3.3x3.5 cm containing calcific foci? subserous fibroid.
- No abdominal or pelvic collections.

III-The scanned skeleton:

- Still seen multiple vertebral small lytic lesions yet no vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

Follow up status showing no gross time interval changes since study dated 25/9/2023.

Signature: Dr. Walid Mohamed, MD

22/08/2024 06:10 ,



Patient Name:	Zeinab Ali Abd El-Zaher abd elkader	Patient Gender:	Female
Patient Code:	Q35077	DATE:	1/15/2023 2:43:32 AM

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- Female patient with history of right breast cancer.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake is seen that would account for bone deposits.
- Arthritic changes of knees are noted.

N.B: focal tracer uptake is seen in the left side of the mandible likely attributed to dental problem for clinical correlation.

Opinion

- No convincing scintigraphic evidence of metastatic osseous lesions.

Dr. Merna Nasef

Dr. Eran Ashraf, MD

د. أحمد كمال النجدي
د. محمد أبو الهدي درويش
د. محمد هاشم علي محمد
د. محمد حسين طاهر
د. ياسر عبد العظيم بدوي
د. أحمد محمد مدني
د. محمد محمد مدني
د. محمد محمد مدني
د. محمد محمد مدني

مركز مصر للأشعة
MISR RADIOLOGY
CENTER



MULTISLICE TRIPHASIC C.T. SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS:-

Multislice post contrast CT scan of the abdomen and pelvis with multiplanar reformatted images revealed:-

FINDINGS:-

- The liver is mildly enlarged showing diffuse fatty texture with no suspicious enhancing hepatic focal lesions detected.
- No intra or extrahepatic biliary dilatation.
- The portal vein is patent with no thrombosis.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas and both suprarenal glands.
- Both kidneys are functioning and normal.
- Normal filling of the urinary bladder with normal wall thickness and no calculi.
- Still noted bulky myomatous uterus with the largest one still seen subserous arising from its anterior fundal wall, currently measures 35.5x28mm (compared to 34x27mm previously), still showing dystrophic calcification within.
- Still noted enlarged heterogeneous both ovaries, with few foci of dystrophic calcification with the largest one currently seen on the right side measuring 31x31.5mm.
- No definite sizable colonic intraluminal soft tissue lesions detected.
- No ascites.
- Bone window still reveals widespread predominantly osteolytic lesions seen randomly distributed along both axial and appendicular skeletons, likely metastatic deposits.

IMPRESSION:-

- Mild fatty hepatomegaly.
- Still noted bulky myomatous uterus with bulky heterogeneous both ovaries, for further workup.
- Multiple widespread osteolytic lesions, mostly metastatic deposits.

PATIENT NAME: ZENEB ALI ABD AL ZAHAR ABD ALKADER	PATIENT ID #: 2020130609
GENDER: Female	ORDER #: 1087477
AGE: 43 y	DATE OF SERVICE: 01-Jun-2021 04:24 PM

Report:

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information :- skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 minutes & 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99mTc-MDP :

Findings:

Compared to previous bone scan dated 24/11/2020, the current study revealed rather stationary course of the previously seen wide spread osseous deposits which are seen involving the axial skeleton and proximal portions of long bones.

No newly seen lesions.

Both kidneys are seen.

Conclusion:-

Compared to 11/2020, the current study revealed rather stationary course of the wide spread metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed



Patient Name: Zainab Ali Abdel Zaher Abdel Kader	Date : 09/12/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 2554/2023	Pat. ID: 42287

**NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

Compared to previous study dated 11/08/2024; the current study revealed

I-Chest:

- Still noted with stationary course of bilateral axillary level I and II enlarged lymph nodes.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Still seen prominent bilateral thyroid lobes with hypodense nodules.

II-Abdomen and pelvis:

- The liver is still seen mildly enlarged with diffuse homogenous low parenchymal CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Still seen calcified uterine fibroid and right adnexal lesion measures about 3.3x3.5 cm containing calcific foci? Sub-serous fibroid.
- No abdominal or pelvic collections.

III-The scanned skeleton:

- Still seen multi-level vertebral and left hemipelvic small lytic lesions yet no vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

Follow up status showing no gross time interval changes since study dated 11/08/2024.

Dr. Yasser Rashad, MSc

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



زینب علی عبدالظاهر (2554/2023)

وزارة الصحة والسكان
لمانه المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

[illegible]

454.

1/5 ع 1 ع 1 ع 1 ع

Premesop. HBC to Bow

f 6/2020 IDC

Ent 1 PM+, 1 to 2-u

1 to 6/2020 1st L AI $\rightarrow$ Dp. 8/2023.

Zobu + Anny + Ibm $\times 3$ L

only 1 does right wt

MOT 2/12

Given 7 PCR Keep in Zobu, Anny 12/12

BS 1/2023 $\rightarrow$ 5/2024 f

CP 8/2024 f

اسم المريض ثلاثي: زينب عبد الله بن عبد الله
رقم الملف: ٢٥٥٤ / ٢٢٣



وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام " هرمل"
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
3/9/2021		This pt. met. Br. Cancer to have Referred for Kank-Al-Ain to receive Aramene + Ibance + Zoladex - Aramene - Calcimata - One alpha قرى يومياً أوامر د/ Lab. on (3/9) ok. Ibance 20/9/21 صيدلية الخارجى	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



اسم المريض ثلاثي: زينة علي عبد ربه
رقم الملف:

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		C.T. CAP: Hox on low S.D. for long mto ع ٣ ٤ - زينة علي ٥ - زينة علي ٦ - زينة علي ٧ - زينة علي ٨ - زينة علي ٩ - زينة علي ١٠ - زينة علي ١١ - زينة علي ١٢ - زينة علي ١٣ - زينة علي ١٤ - زينة علي ١٥ - زينة علي ١٦ - زينة علي ١٧ - زينة علي ١٨ - زينة علي ١٩ - زينة علي ٢٠ - زينة علي ٢١ - زينة علي ٢٢ - زينة علي ٢٣ - زينة علي ٢٤ - زينة علي ٢٥ - زينة علي ٢٦ - زينة علي ٢٧ - زينة علي ٢٨ - زينة علي ٢٩ - زينة علي ٣٠ - زينة علي ٣١ - زينة علي ٣٢ - زينة علي ٣٣ - زينة علي ٣٤ - زينة علي ٣٥ - زينة علي ٣٦ - زينة علي ٣٧ - زينة علي ٣٨ - زينة علي ٣٩ - زينة علي ٤٠ - زينة علي ٤١ - زينة علي ٤٢ - زينة علي ٤٣ - زينة علي ٤٤ - زينة علي ٤٥ - زينة علي ٤٦ - زينة علي ٤٧ - زينة علي ٤٨ - زينة علي ٤٩ - زينة علي ٥٠ - زينة علي ٥١ - زينة علي ٥٢ - زينة علي ٥٣ - زينة علي ٥٤ - زينة علي ٥٥ - زينة علي ٥٦ - زينة علي ٥٧ - زينة علي ٥٨ - زينة علي ٥٩ - زينة علي ٦٠ - زينة علي ٦١ - زينة علي ٦٢ - زينة علي ٦٣ - زينة علي ٦٤ - زينة علي ٦٥ - زينة علي ٦٦ - زينة علي ٦٧ - زينة علي ٦٨ - زينة علي ٦٩ - زينة علي ٧٠ - زينة علي ٧١ - زينة علي ٧٢ - زينة علي ٧٣ - زينة علي ٧٤ - زينة علي ٧٥ - زينة علي ٧٦ - زينة علي ٧٧ - زينة علي ٧٨ - زينة علي ٧٩ - زينة علي ٨٠ - زينة علي ٨١ - زينة علي ٨٢ - زينة علي ٨٣ - زينة علي ٨٤ - زينة علي ٨٥ - زينة علي ٨٦ - زينة علي ٨٧ - زينة علي ٨٨ - زينة علي ٨٩ - زينة علي ٩٠ - زينة علي ٩١ - زينة علي ٩٢ - زينة علي ٩٣ - زينة علي ٩٤ - زينة علي ٩٥ - زينة علي ٩٦ - زينة علي ٩٧ - زينة علي ٩٨ - زينة علي ٩٩ - زينة علي ١٠٠ - زينة علي	

صيدلية الخارجية

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

توقيع الطبيب	الأوامر	الوقت	التاريخ
C3	Dr. A. H. 18/1/2024 700 mg 1. tramadol 2x 1x 30 Ibuprofen 100 mg 1x 21 C. C. 11-11 C. C. 11-11	labs taken for ibuprofen 18/1/2024 استدعى	18/1/2024

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

نوع التغطية :-

التشخيص:

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



رقم الملف:
 اسم المريض ثلاثي:

Doctor's Orders **أوامر الطبيب**

التفصيل:	نوع التغذية:
----------	--------------

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



اسم المريض ثلاثي: محمد بن عبد الله
رقم الملف: ٢٠٢٢

Doctor's Orders **أوامر الطبيب**

التشخيص: نوع التظلية:

[illegible]

الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التعليق: نوع التغطية:

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

CAP/2074
(29/6/2074)

Page 1 of 1

رقم الملف:

نوع التغذية :

التّشخيص:

SMC-DSH-F-PHY-G-010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 1/7/2022

لأوامر الطبية لا بد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Labs are OK
For Ibrance
22/8/2024
✓LW:wp

Page

رقم الملف:
 اسم المريض ثلاثي:



التشخيص:	نوع التغذية:
.....	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

ph reports she didn't rec
face

SMC-USH-F-PHY-G010
Revision no: 2
Issue no: 3
Issue Date: 17/2/2022

وزارة الصحة و السكان
أمثلة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التخصيص:	نوع التغذية:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		اروحان زیدہ ع۔ س۔ ل۔ س۔ ع۔ نور کبر زولایکھہ صریحاً ایضاً عرو ۱۱/۱۸ ابو عبد ۱۱/۱۸ دور ع۔ ع۔	۱۸/۱۱/۲۰۱۷

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

رقم الملف:

457.

b7

التفصيل:	نوع التغذية:
----------	--------------

توقيع الطبيب	الأوامر	الوقت	التاريخ
9/12/2024	MDT 2/12/2024 Anxiety CR Keep on Zoltek + Amogam, Zolite / BS SM on 4/1/2025 partial Radiological Rep of Mr B... BS 5/2024 CR 8/2024 over CR for ① Dental and ② New CT ③ Bone scan		

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أوران دار السلام " هرميل"
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التظنية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Dentist Dear Dr, The patient has a tooth that needs to be extracted however, she refused to do so and wishes to proceed with zometa. Dr. Faten Ali 15/1/2025	

→ رئيس
11/10

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders اوامر الطبيب

التعخيص:	نوع التقنية:
----------	--------------

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		gladness Prima climax quero	ادخلو في + دوسو سهرات ١٢/١٧

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
22/6/2022		Bone Scan → CR (no active lesions) for R / Axillary 1x1x30 R / Ob. Abdom 1x1x90 R / Calceus 1x1x90 2000 mg Zoledronic acid after 2 months أفيل + أدريسيل روماتيزم (ع) وريد زوكادكس 1.8 غم سينادول 500 C.C. 11/17 مراجعة مخبر	

Clinical pharmacy
Zometa Zoledronic acid
رقم الدواء
C.C. 11/17

جميع الأوامر الطبية لا بد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض ثلاثي:
.....

رقم الملف :